

Распределение гистологических типов рака легкого по регионам Республики Азербайджан

Солтанов А.А.

Национальный Центр Онкологии, Баку

Распределение гистологических типов рака легкого по регионам Республики Азербайджан.

А.А.Солтанов

Национальный Центр Онкологии, Баку

В Азербайджане, в структуре заболеваемости и смертности злокачественных опухолей среди мужчин на первом месте стоит рак легкого. Изучено распространение различных гистопатологических форм рака легкого в Азербайджане, также влияния отдельных факторов, таких как пол, региональных особенностей, вредных привычек на гистопатологию рака легкого. Материалами исследования явились истории болезни 876 больных, обследованные и получившие лечение по поводу рака легкого в Национальном Центре Онкологии и Бакинском городском диспансере в период с 1995 по 2003 год. Территория Азербайджанской республики была условно разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные административные районы, и больные были распределены по этим регионам, согласно их месту жительства. Во всех регионах наиболее часто встречаемым гистологическим типом оказался плоскоклеточный рак. Самый высокий показатель плоскоклеточного рака 230 (55,56%) отмечен в регионе «Большой Кавказ». Этот гистологический тип независимо от пола превалирует и составляет 54,41% среди всех форм рака легкого. Плоскоклеточный рак диагностирован у 213 (59%), аденокарцинома у 37 (10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), крупноклеточный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), другие формы (недифференцированные) у 38 (10,53%) среди 361 больных с центральным раком легкого. Выявлено, что табакокурение и одновременное употребление спиртных напитков повышает риск развития рака легкого. Больше половины (53,5%) больных помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки.

Рак легкого – одна из самых распространенных форм злокачественных новообразований [4,9]. Ежегодно отмечается в мире с 1.3 миллион новых случаев заболеваемости данной нозологической формой злокачественных новообразований, диагностируемых каждый год [6].

В Азербайджане, как и во всем мире, в структуре заболеваемости и смертности злокачественных опухолей среди мужчин на первом месте стоит рак легкого [3]. Так, среди лиц мужского пола, заболеваемость раком легких у нас в республике составляет около 20%, а у женщин 3,3%. Показатели смертности от рака легкого в Азербайджане последние 10 лет не изменились [2].

Ряд авторов описывают изменение показателей заболеваемости и смертности в Европейской зоне в XX столетии в зависимости от гистологических подтипов рака легких [8].

Распределение рака легкого географически неоднородно [7]. Показатели заболеваемости рака легкого резко меняются между различными областями мира. Самые высокие показатели заболеваемости рака легкого у мужчин

Distribution Of Different Histological Types Of Lung Cancer In Regions Of Azerbaijan

Soltanov A.A.

National Center of Oncology, Baku.

The lung cancer is at the first place due to morbidity and mortality in the structure of oncological diseases among males in Azerbaijan. The spread of the different histological forms of lung cancer in Azerbaijan, and also the influence certain factors, like a sex, regional features, bad habits, to histopathology of lung cancer were researched. The materials of study were the case histories of 876 patients, who were observed in National Center of Oncology and Baku's City's dispensary during period of time from 1995 to 2003. The territory of Azerbaijan was conditionally divided to 5 regions, in which separate administrative regions were included, and patients were distributing to these due to their domicile. In all regions the most common histological type was squamous cell carcinoma. The highest rate of squamous cell carcinoma 230 (55.56%) was noted in The Big Caucasus region. This histological type independent from sex amount 54.41% between other types of lung cancer. The squamous cell carcinoma was diagnosed in 213 (59%), adenocarcinoma in 37 (10.25%), small cell carcinoma in 6 patients (1.66%), large cell carcinoma in 6 (10.53%) patients within 361 with central lung cancer. It was revealed that smoking and alcoholic drinks increases risk of lung cancer. More than the half of the patients (53.5%) besides smoking were alcoholic drinkers.

отмечены в Европе, особенно в центральной и Восточной Европе, и в северной Америке. В пределах Европы самые высокие мужские показатели заболеваемости отмечены в Венгрии и Польши, а самые низкие в Швеции и Мальте [6].

Рак легкого могут быть разделены на две главные типы: мелкоклеточный рак (SCLC) и немелкоклеточный рак легкого (NSCLC) [1, 14, 11]. Мелкоклеточный рак (SCLC) - самая агрессивная форма рака легкого, с большим потенциалом к метастазированию, чем другие типы рака легкого. Почти все больные (более чем 95 %) у которых диагностирован мелкоклеточный рак легкого, являются запущенными и ранее курильщиками.

Немелкоклеточный рак легкого (NSCLC) - гетерогенная группа, основные подтипы – плоскоклеточный рак и аденокарцинома легкого.

Эти опухоли способны расти в центре легкого, и приобретать большие размеры. Аденокарциномы обычно развиваются в периферии легкого. Хотя это распространенный тип рака легкого, наиболее часто отмечается у некурящих [13], однако за последние многие годы курение считается все больше причиной аденокарциномы легкого [18].

Плоскоклеточный рак легкого составляет более высокую пропорцию рака легкого [17], диагностированных среди мужчин, чем женщин, тогда как частота аденокарциномы легкого больше, среди женщин по сравнению с мужчинами [14]. Среди мужчин, плоскоклеточный рак был самым частым гистологическим типом рака легкого в Корее (46 %), Франции (41 %) и Великобритании (40 %), тогда как аденокарцинома

Таблица 1. Распространение рака легкого по регионам Республики и гистологическим типам опухоли

Гистология	«Большой Кавказ»	«Куринская межгорная низменность»	«Малый Кавказ»	«Нахичевань»	«Ленкорань»	Итого
Плоскоклеточный	236 73,29%	49 15,22%	21 6,52%	4 1,24%	12 3,73%	322 54,48%
Аденокарцинома	50 75,76%	13 19,7%	-	-	3 4,55%	66 11,17%
Мелкоклеточный	9 81,82%	1 9,09%	1 9,09%	-	-	11 1,86%
Крупноклеточный	6 100%	-	-	-	-	6 1,02%
прочие	78 63,41%	25 20,33%	9 7,32%	1 0,81%	10 8,13%	123 20,81%
Диморф (плоско+аднокарц)	45 71,43%	8 12,70%	8 12,70%	-	2 3,17%	63 10,66%
Итого	424 71,74%	96 16,24%	39 6,60%	5 0,85%	27 4,57%	591 100%

больше всего была распространена в Соединенных Штатах (31 %), Канаде (31 %), Швеции (30 %), и Австралии (29 %). За исключением Великобритании (где 28 % случаев рака легкого среди женщин был плоскоклеточный рак), аденокарцинома легких составляли самую большую часть рака легкого среди женщин по сравнению указанных стран (в пределах от 38 % в Соединенных Штатах до 69 % в Японии) [5]. Мелкоклеточный рак легкого составил от 14 % (Австралия и Япония) до 17 % (Корея и Великобритания) рака легкого среди мужчин, и от 9 % (Япония) до 22 % (Великобритания) среди женщин [19].

Несмотря на обширное исследование, механизмы, приводящие к этим различным типам рака легкого, остаются неизученными. За последние десятилетия были и географические и временные изменения в распределении типов рака легкого [10, 12, 15].

Знание этих модификаций может помочь определить основные новые этиологические и патологические механизмы рака легкого. Аденокарцинома легкого стала ведущим гистологическим типом в Северной Америке [16], Европе [10] и Азии [12].

Целью

настоящего исследования явилось изучение распространения различных гистологических форм рака легкого в Азербайджане в зависимости от возможных факторов риска.

Материал и методы

Материалами исследования явились данные 876 больных раком легкого, обследованных в Национальном Центре Онкологии за период 1995–2003 гг. Средний возраст больных составил 53 года. Диагноз рака легкого установлен у 29,2% больных на основании цитологического, у 53,9% гистологического и у 16,9% обоих методов исследования. У 591 (67,5%) больных удалось определить гистологический тип опухоли. Плоскоклеточный рак установлен у 322 (54,5%), аденокарцинома у 66 (11,2%), мелкоклеточный рак у 11 (1,9%), крупноклеточный рак у 6 (1%), смешанный рак (плоскоклеточный рак + аденокарцинома) у 63 (10,6%) и прочие формы рака диагностированы у 123 (20,8%) больных.

Территория Азербайджанской республики была условно разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные административные районы. Эти регионы отличаются климатогеографическими условиями и культурно-традиционными обычаями населения. В сравниваемых группах учтены региональные особенности гистологических типов рака легкого.

Регион «Большой Кавказ» охватывает в основном природную область Большого Кавказа, занимает первое место по площади, численности населения,

городских жителей и экономической мощи.

Более половины территории региона «Куринская межгорная низменность» расположено ниже уровня моря. Будучи первым, по площади и вторым – по численности населения экономическим регионом республики, развит химической промышленностью. В регионе также развита химическая промышленность, машиностроение, легкая, пищевая промышленность.

Регион «Малый Кавказ» простирается от границ с Грузией до Иранской границы. 28% территории республики, 23% населения приходится на долю этого района. Сложность рельефа дает возможность выделить здесь 4 зоны с точки зрения освоенности территории: Гянджа-Газахская наклонная равнина, где развито орошаемое земледелие; предгорная зона – земледелие и животноводство; среднегорья – богарное земледелие (здесь находится основные месторождения полезных ископаемых); высокогорная зона – летние пастбища и животноводство.

IV регион Республики «Нахичевань» расположено отдельно от основной территории Азербайджана, на границе с Турцией, Ираном и Арменией и имеет резкий континентальный климат и сложный рельеф

«Ленкорань» – расположена на юго-востоке республики. Пограничное расположение с Ираном и близость к морю – благоприятные черты ЭГП (экономико-географическое положение). Наличие влажного субтропического климата, низменного и низкогогорного рельефа, плодородные почвы считаются положительными чертами природных условий. 25% населения живет в городах. Основу экономики района составляет АПК (агропромышленный комплекс).

Из 565 опрошенных больных 148 (26,02%) были только курильщиками, 243 (43,01%) помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки (алкоголь), 4 (0,71%) только употребляли спиртные напитки, только 171 (30,27%) отрицали вредных привычек у них в анамнезе. Сформированные по отдельным признакам группы больных подвергнуты однофакторным и многофакторным анализам. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета программ STATISTICA-6 Base (Basic Statistical Analysis Methods) с использованием 2-Way table summary. Из-за отсутствия данных в некоторых историях болезни по отдельным изучаемым вопросам, эти больные исключены из исследования самой программой автоматически. Поэтому общее число больных в сравниваемых групп отличались.

Результаты и обсуждение

Анализируя данные по территориальной распространенности рака легкого среди населения Азербайджанской республики, следует констатировать, что во всех регионах наиболее часто встречаемым гистологическим типом оказался плоскоклеточный рак.

Плоскоклеточный рак диагностирован у 322 (54,5%) больных. Высокая частота плоскоклеточного рака 236 (73,3%) отмечен в регионе «Большой Кавказ». Это можно связать с большой плотностью населения в этом регионе, по сравнению с другими, а также наличием в этом регионе таких крупных промышленных городов, как Баку и Сумгаит. Низкая частота плоскоклеточного рака наблюдалась в регионе «Нахичевань» (1,24%), находящемся на гористой местности, и с отсутствием индустриализации в городах этого региона (Рис.1 и табл.1).

Аденокарцинома легких диагностирована у 66 (11,2%) больных. Среди них 50 (75,8%) больных были жителями региона «Большой Кавказ», 13 (19,7%) региона «Куринской межгорной низменности», 3 (4,5%) жителями

Таблица 2. Распределение больных раком легкого по полу и гистологическим типам опухоли

Пол больных	Плоскоклеточный	Аденокарцинома	Мелкоклеточный	Крупноклеточный	прочие	Диморф (плоско+Аденокарцинома)	итого
Мужчины	288	57	10	4	110	62	531
	54,24%	10,73%	1,88%	0,75%	20,72%	11,68%	89,85%
Женщины	34	9	1	2	13	1	60
	56,67%	15,00%	1,67%	3,33%	21,67%	1,67%	10,15%
Итого	322	66	11	6	123	63	591
	54,48%	11,17%	1,86%	1,02%	20,81%	10,66%	100%

Таблица 3. Распределение больных раком легкого по гистологической структуре и наличия вредных привычек в анамнезе

Вредные привычки	Плоскоклеточный	Аденокарцинома	Мелкоклеточный	Крупноклеточный	прочие	Диморф (плоско+аденокарц)	итого
Курение	90 61.22%	14 9.52%	2 1.36%	1 0.68%	23 15.65%	17 11.56%	147 26.02%
Употребление спиртных напитков	2 50.00%	2 50.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4 .71%
Одновременное употребление табака и алкоголя	130 53.50%	20 8.23%	3 1.23%	1 0.41%	59 24.28%	30 12.35%	243 43.01%
Вредных привычек отрицает	88 51.46%	24 14.04%	5 2.92%	4 2.34%	35 20.47%	15 8.77%	171 30.27%
Итого	310 54.87%	60 10,62%	10 1.77%	6 1.06%	117 20.71%	62 10.97%	565 100.00%

региона «Ленкорань». Определенную связь гистологических типов рака легкого регионами Республики выявить не удалось. Отмечено высокая частота плоскоклеточного и недифференцированного («прочие») типов рака легкого.

Независимо от регионов, можно заметить, что больные раком легкого мужского пола встречались в несколько раз чаще, чем женского. Соотношение больных мужчин и женщин для Республики составило 8,8/1. Половое соотношение для плоскоклеточного и недифференцированного («прочие») рака легкого составило 8,5/1, для аденокарциномы 6,3/1, мелкоклеточного рака 10/1, крупноклеточного рака 2/1 и смешанного рака 62/1.

Половое соотношение для отдельных гистологических типов рака легкого изучено и для отдельных регионов (Табл.2 и Рис.2).

Мужское и женское соотношение плоскоклеточного рака в регионе «Большой Кавказ» было, почти одинаково Республиканского соотношения, составив 8,8/1 (212 мужчин/24 женщины). Это соотношение составило для региона «Куриной межгорной низменности» 11,2/1 (45м/4ж), для «Малого Кавказ» 6/1 (18м/3ж), для «Нахичевань» 4/0 (4м/0ж), для региона «Ленкорань» 3/1 (9м/3ж).

Для аденокарциномы это соотношение в регионе «Большой Кавказ» составило 4,5/1 (41муж./9 жен.), для региона «Куриная межгорная низменность» 13 (13м/0ж), для региона «Ленкорань» 3 (3м/0ж). В остальных регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Для мелкоклеточного рака это соотношение в регионе «Большой Кавказ» составило 8/1 (8муж./1 жен.), для региона «Куриная межгорная низменность» 1 (1м/0ж), для региона «Малый Кавказ» 1 (1м/0ж). В остальных регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Все 6 случаев крупноклеточного рака легкого диагностированы у жителей региона «Большой Кавказ».

Для недифференцированных («прочие») форм рака легкого половое соотношение для регионов: «Большой Кавказ» - 5,5/1 (66м/12ж); «Куриная межгорная низменность» - 24/1 (24м/1ж); «Малый Кавказ» - 9 (9м/0ж); «Нахичевань» - 1 (1ж/0ж) и «Ленкорань» - 10 (10м/0ж).

Для смешанного (плоскоклеточный + аденокарци-

нома) рака легкого половое соотношение для регионов составило: «Большой Кавказ» - 44/1 (44м/1ж); «Куриная межгорная низменность» - 8 (8м/0ж); «Малый Кавказ» - 8 (8м/0ж); и «Ленкорань» - 2 (2м/0ж).

Плоскоклеточный рак легкого среди мужчин, так и среди женщин превалирует и составляет большую часть (54,48%) всех форм рака (табл.№2). Независимо от гистологической структуры опухоли соотношение больных по полу составило как 9/1. Из 591 больных раком легкого 89,85% были мужчины, 10,15% женщины.

Анализируя данные больных, выявлено, что наличие или отсутствие вредных привычек у них в анамнезе были внесены только в 565 истории болезни. 147 (26%) из них были курильщиками, 4 (0,71%) только употребляли спиртные напитки, 243 (43%) помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки, только 171 (30,3%) отрицали нали-

чия у них вредных привычек. Среди больных плоскоклеточным раком 130 (41,94% из 310), аденокарциномой легкого 20 (33,33% из 60), смешанной формой рака 30 (48,39% из 62), прочими формами рака 59 (50,43% из 117) больных помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки.

Плоскоклеточный рак превалирует по сравнению другими формами рака. Плоскоклеточный рак одинаково часто диагностирован среди этих сравниваемых групп. Среди курильщиков плоскоклеточный рак выявлен у 61,22%, среди больных которые употребляли только спиртные напитки у 50%, среди больных, которые помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки у 53,50% и среди больных которые отрицали вредных привычек в анамнезе 51,46% случаев. Высокий процент плоскоклеточного рака среди больных (88 (51,46%) из 171), которые отрицали вредных привычек у них в анамнезе, возможно, объясняется тем, что большинство 120 (70,2%) из них явились городскими жителями. Роль загрязнения окружающей городской среды у этой категории больных неизбежно.

Изучены гистологических типов рака легкого среди больных с различным клинико-анатомическим ростом опухоли. Среди 361 больных с центральным раком легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 213 (59%), аденокарцинома у 37 (10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), крупноклеточный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), другие формы (недифференцированные) у 38 (10,53%).

Среди 124 больных с периферическим раком легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 56 (45,15%), аденокарцинома у 16 (12,9%), мелкоклеточный рак у 3 (2,42%), смешанный рак у 36 (29%), другие формы (недифференцированные) у 13 (10,48%).

Среди 100 больных с атипическим (медиастинальная форма роста) раком легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 48 (48%), аденокарцинома у 13 (13%), мелкоклеточный рак у 2 (2%), смешанный рак у 25 (25%), другие формы (недифференцированные) у 12 (12%).

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно заключить, что плоскоклеточный рак превалирует среди больных по сравнению с другими гистологическими

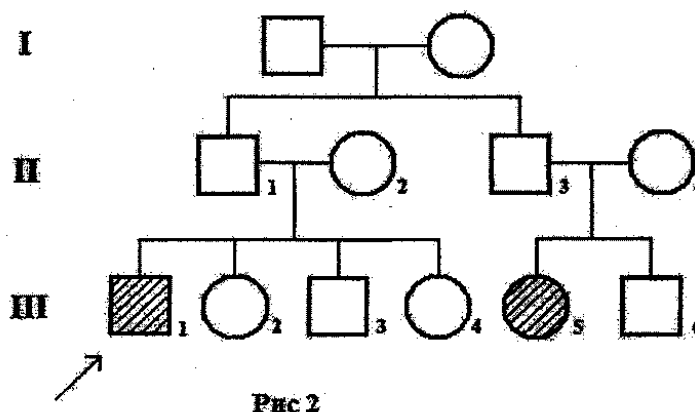


Рис 2

Рисунок 1. Распространение рака легкого по регионам Республики и гистологическим типам опухоли.

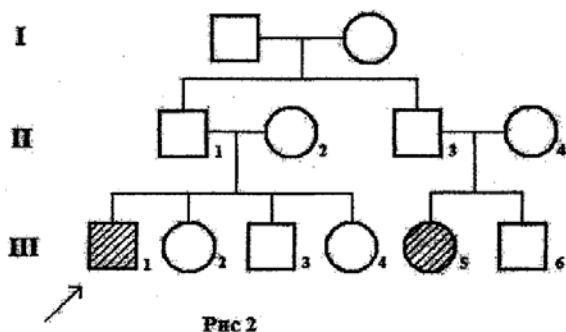


Рис 2

Рисунок 2. Распределение больных раком легкого по 5 регионам Республики, по полу и гистологическим типам опухоли

типами рака легкого. Половое соотношение рака легкого для всех видов рака легкого сохраняется в пользу мужчин и для всех регионов Республики. Высокие проценты рака легкого в регионе «Большой Кавказ» возможно, связаны с воздействием факторов внешней среды, таких как сигаретный дым, а также загрязнением атмосферного воздуха, поскольку регион включает индустриальные города как Баку и Сумгаит [3]. Курение и одновременное употребление спиртных напитков повышает риск развития рака легкого среди мужчин. Эти вредные привычки, в связи с менталитетом народов, проживающих на территории Азербайджанской Республики, характерно в основном для мужского населения, что и связано высокой частоты рака среди мужчин.

Список использованной литературы

1. Бычков М.Б. Мелкоклеточные рак лёгкого. Эволюция химиотерапии за последние 20 лет // *Мат. III съезда онкологов и радиологов СНГ*. - Минск, 2004. - Ч. 1. - С. 151-153.
2. Солтанов А.А. Заболеваемость и смертность от рака легкого в Азербайджане // *Азербайджанский журнал онкологии*

и гематологии. - 2005. - №2. - С.37-39.

3. Солтанов А.А. Эпидемиологические особенности рака легкого в Азербайджане // *Азербайджанский журнал онкологии и гематологии*. - 2007. - №1. - С.20-26.
4. Bahader Y., Jazieh A. Epidemiology of lung cancer // *Ann. Thorac Med.* - 2008. - Vol. 3. - P.65-67.
5. Curado M.P., Edwards B., Shin H.R. et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. 9. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC) 2007. IARC Scientific Publications No. 160.
6. Ferlay J., Autier P., Boniol M. et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006 // *Ann. Oncol.* - 2007. - Vol.18, N3. - P.581-592.
7. Gilliland F.D., Samet J.M. Incidence and mortality for lung cancer: geographic, histologic, and diagnostic trends // *Cancer Surv.* - 1994. - Vol.19. - P.175-195.
8. Janssen-Heijnen M.L., Coebergh J.W. The changing epidemiology of lung cancer in Europe. Eindhoven Cancer Registry, Comprehensive Cancer Centre South, P.O. Box 231, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. m.janssen@ikz.nl Lung // *Cancer*. - 2003. - Vol.41, N 3. - P.245-258.
9. Jemal A., Murray T., Ward E. et al. Cancer Statistics, 2005 // *CA Cancer J. Clin.* - 2005. - Vol.55. - N 1. - P.10-30.
10. Levi F., Franceschi S., La Vecchia C., Randimbison L., Te V.C. Lung carcinoma trends by histologic type in Vaud and Neuchatel, Switzerland, 1974-1994 // *Cancer*. - 1997. - Vol.79. - N 5. - P.906-914.
11. Molina J.R., Yang P., Cassivi S.D. et al. Non-Small Cell Lung Cancer: Epidemiology, Risk Factors, Treatment, and Survivorship // *Mayo Clin. Proc.* - 2008. - Vol. 83, N 5. - P. 584 - 594.
12. Morita T. A statistical study of lung cancer in the annual of pathological autopsy cases in Japan from 1958 to 1997 with reference to time trends of lung cancer in the world // *Jpn. J. Cancer Res.* - 2002. - Vol. 93, N 1. - P. 15-23.
13. Subramanian J., Govindan R. Lung cancer in never smokers: a review // *J. Clin. Oncol.* - 2007. - Vol. 25. - P.561-570.
14. Sun Z., Aubry M.-C., Deschamps C. et al. Histologic grade is an independent prognostic factor for survival in non-small cell lung cancer: An analysis of 5018 hospital- and 712 population-based cases // *J. Thorac. Cardiovasc Surg.* - 2006. - Vol.131. - P.1014-1020.
15. Travis, W. D., World Health Organization., International Agency for Research on Cancer., International Academy of Pathology & International Association for the Study of Lung Cancer. Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart (IARC Press, Lyon, 2004).
16. Travis W.D., Garg K., Franklin W.A. et al. Evolving concepts in the pathology and computed tomography imaging of lung adenocarcinoma and bronchioloalveolar carcinoma // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol. 23, N 14. - P. 3279-3287.
17. Wistuba Ignacio I. Histologic Evaluation of Bronchial Squamous Lesions: Any Role in Lung Cancer Risk Assessment? // *Clinical Cancer Res.* - 2005. - N 11. - P. 1358.
18. Yang P., Cerhan J.R., Vierkant R.A. et al. Adenocarcinoma of the lung is strongly associated with cigarette smoking: further evidence from a prospective study of women // *Am. J. Epidemiol.* - 2002. - Vol.156, N12. - P.1114-22.
19. Youliden, Danny R. BSc; Cramb, Susanna M. et al. The International Epidemiology of Lung Cancer: Geographical Distribution and Secular Trends. // *J. of Thoracic Oncology*. - 2008. - Vol.3, N 8. - P.819-831.

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскоклеточным раком кожи

Алиева К.А., Гасанова А.Х.

Бакинский государственный университет, Азербайджанская Республика

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскоклеточным раком кожи

На основании анализа 95 родословных с плоскоклеточным раком кожи нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования заболевания. В экспериментальной группе коэффициент инбридинга и частота эндогамных браков составили $F=0,0067$ и 43,98% соответственно, что не отличаются от средних Республиканских показателей.

Актуальность проблемы

Плоскоклеточная или сквамозно-клеточная карцинома развивается из клеток, лежащих над базальным слоем эпителия. Встречается реже базалиомы, которые включают в себя несколько основных разновидностей: болезнь Боуэна, болезнь Кейра, боуэноподобный папулез и инвазивный плоскоклеточный рак - наиболее опасная форма заболевания, напоминающая болезнь Боуэна, но края папул нечеткие и имеют склонность к изъязвлению и легкой травматизации. Синдромы дефицита, такие как синдром Пламмера-Винсона, характеризующегося дисфагией, железodefицитной анемией, пищеводных пленок, встречаются все реже с улучшением условий питания в развивающихся странах (3,4,8,9). Данные экспериментальных и эпидемиологических исследований показали, что УФ-излучение является канцерогенным для человека и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы кожи (5).

Следует отметить недостаточную освещенность в отечественной и зарубежной литературе результатов исследований по изучению генетики плоскоклеточного рака кожи, что открывает перед исследователями определенные перспективы.

Материалы и методы исследований

Клинико-генеалогический анализ - составление и анализ родословных для установления типа наследования, определения типа кровнородственного брака, а также вычисления коэффициента инбридинга проводили по (3,4,7). Для клинико-генеалогических исследований нами составлен и проведен анализ родословных 95 пробандов.

Результаты собственных исследований

На основании клинико-генеалогических исследований 95 родословных больных - пробандов, нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования плоскоклеточного рака кожи. Определена структура браков и вычислен коэффициент инбридинга в этих семьях. Среднее количество детей и средний размер семьи у пробандов с плоскоклеточным раком кожи составил 4,2 и 6,2, соответственно. Эти показатели для больных мужчин и больных женщин соответственно составили - 4,1; 6,1 и 4,3; 6,3, и отличаются статистически недостоверно. Нам было интересно узнать порядок рождения больного мальчика и больной девочки в семье. Результаты клинико-генеалогического анализа ядерных семей пробандов пред-

Clinical-Genealogical Analysis Of Families With Skin Squamous Cell Carcinoma

K.A.Aliyeva, A.X.Hasanova

For the first time we identified multifactorial inheritance type of skin squamous cell carcinoma on the basis of 95 family trees analysis. Inbreeding coefficient and endogamous marriage frequencies comprised $F=0,0067$ and 43,98%, respectively, that did not differ from average indications in the Republic.

ставлены в таблице № 1.

Как видно из таблицы № 1, наблюдалось снижение количества больных детей от количества деторождения: следовательно, больные в независимости от пола в 40,0% случаях были первенцами, в 30,53% случаях вторыми по рождению, в 17,89%) случаях третьими, 7,36% четвертыми, 3,16%о пятими и в одном случае - 1,05% шестым. Эту закономерность также можно объяснить возрастом ребенка-больного, чем старше человек тем чаще, выше вероятность заболеть онкологическим заболеванием, в частности плоскоклеточным раком кожи.

В наших исследованиях в трех семьях наблюдали заболевание у разнополых сибсов, т.е. у брата и сестры, и в одном случае у двух двоюродных сестер по отцовской линии. В этих четырех семьях только в одном случае выявили кровное родство между родителями больного. В остальных трех случаях наблюдали эндемичный тип брака. На рисунках № 1. и №2. представляем родословные пробандов М.К. и Т.Е.

Как видно из рисунка №1. пробанд - IV-1 является первым, а больная сестра - IV-3 третьим ребенком в семье. Отец - III-1 и мать - Ш-2 имеют кровное родство второй степени, т.е. двоюродный брат и двоюродная сестра. Их матери являются родными сестрами (П-1, П-4).

На рисунке №2. пробанд Т.Е. (III-1) и двоюродная сестра (Ш-5) имеют заболевание кожи. Пробанд Т.Е. (III-1) является первым из четырех детей, двоюродная сестра (Ш-5) также первая из двух детей в семье. П-1 и П-3 являются родными братьями.

Внутрисемейная частота плоскоклеточного рака кожи соответствует -1,23, что характерно для мультифакториального типа наследования заболевания. Следовательно, для возникновения заболевания необходимо изменение в группе генов под воздействием эндогенных и экзогенных факторов (8).

Сегрегационный анализ патологического признака в родословной не установил такие типы наследования как аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный и сцепленный X-половой хромосомой.

В структуре браков в семьях пробандов с плоскоклеточным раком кожи частота двоюродного, троюродного и четвероюродного типов кровнородственных браков составили; 5,26%, 6,32% и 9,47% соответственно.

Коэффициент инбридинга в экспериментальной группе составил $-F=0,0067$, что соответствовало средней популяционной частоте коэффициента инбридинга по Республике - $F=0,0066$ (1-4).

Частота эндогамных браков составил - 44,21%),

Таблица № 1. Результаты клинико-генеалогического анализа семей пробандов

Порядок рождения			девочка		всего	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
1-й ребенок	17	36,96	21	42,86	38	40,0
2-й ребенок	13	28,26	16	32,65	29	30,53
3-й ребенок	12	26,01	5	10,20	17	
4-й ребенок	2	4,35	5	10,20	7	
5-й ребенок	2	4,35	1	2,04	3	
6-й ребенок	-	1		2,04	1	

что также соответствует средней популяционной частоте эндогамных браков по Республике -43,98%.

Таким образом, путем клинико-генеалогических исследований нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования плоскоклеточного рака кожи. В этих семьях коэффициент инбридинга и частота эндогамных браков соответственно составили $F=0,0067$ и 43,98%, что соответствовало средним Республиканским показателям.

Выводы

На основании анализа родословных нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования плоскоклеточного рака кожи.

В экспериментальной группе коэффициент инбридинга и частота эндогамных браков составили $F=0,0067$ и 43,98% соответственно, что не отличается от средних республиканских показателей.

Литература

1. Алиева К.А., Расулов Э.М. Популяционно-генетические и демографические исследования некоторых районов Азербайджанской Республики. Второй Российский съезд медицинских генетиков, Курск, 17-19 мая 2000, т.1. с.151.
2. Мухтаров З.Я., Алиева К.А., Расулов Э.М. Популяционно-генетические исследования в Лерикском районе Азербайджанской Республики. Ж.Цитология и генетика, Киев, 2000, №5, с.22-29.
3. Козлова СИ., Демикова Н.С., Семанова Е. и др. Наслед-

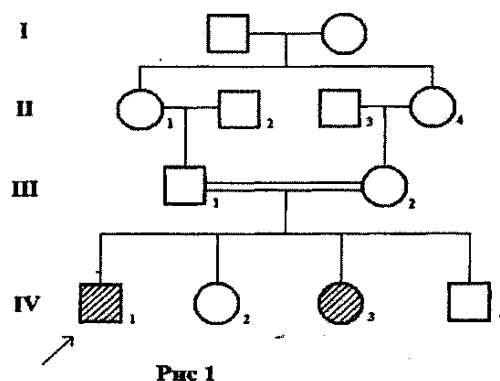


Рис 1

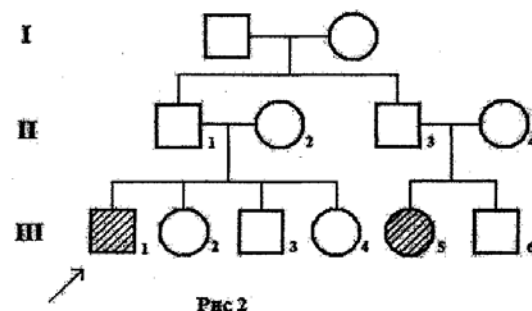


Рис 2

ственные синдромы и медико-генетическое консультирование: Справочник. 2-е издание. Москва. Практика. 1996.

4. Козлова СИ., Семенова СО, Демикова Н.С., Блинникова О.Е.. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. Ленинград, 1987.
5. Кропотов М.А. Срединная мандибулотомия как средство оперативного доступа у больных местнораспространенным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки // Рос. онкол. журн. - 2002. - №2. - С.34-37.
6. Липкин Е.Е., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников Н.Б. Генетика для врачей. Москва. Медицина. 1990. с.255.
7. Харлер П. Практическое медико-генетическое консультирование. Москва. Медицина. 1984. с. 280.
8. McKusick A. Mendelian inheritance in man. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London. Tenth edition. V. 1,2. 2002. p. 1167.
9. H-Parkes M., Barmada M.M., Satsangi J. et al., The IBD2 locus show linkage heterogeneity between ulcerative colitis and Crohn disease. AmJ.Hum.Genet.2000. 67(6): 1605-1610.